

	Umgang mit Arzneimitteln	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Diese Checkliste fasst wichtige Punkte zur sicheren und korrekten Handhabung von Arzneimitteln zusammen.

1. Lagerung von Arzneimitteln

- Arzneimittel müssen unter Verschluss und gesichert vor Zugriff durch Unbefugte aufbewahrt werden.
Sie müssen vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.
- Halten Sie eine übersichtliche Lagerung ein:
 - Sortieren nach Alphabet
 - Übervorräte meiden
 - Anbruch von nur einer Originalpackung pro Arzneimittel
 - Angebrochene Packungen kennzeichnen, zum Beispiel mit einem Kreuz oder einem Etikett
- Arzneimittel mit dem kürzesten Verfall immer zuerst verbrauchen
 - ❖ **„FeFo-Prinzip“ (first expired – first out).**
- Seitenlaschen oder Deckel der Originalpackungen nicht abreißen, damit Verfalldatum und Chargennummer nicht entfernt werden.
- Belassen Sie die Blister in der Originalverpackung.
 - Die Originalverpackung bietet dem Arzneimittel Schutz vor direktem Sonnenlicht und in gewissem Maße auch vor Feuchtigkeit.
 - Im Falle eines Chargenrückrufes müssen die Blister nicht erst zusammengesucht werden bzw. es wird vermieden, dass sie übersehen werden.
- **Vermischen Sie keinesfalls unterschiedliche Chargen in einem Umkarton.**
 - Unterschiedliche Chargen haben oftmals auch unterschiedlichen Verfall. Somit wäre die Einhaltung des FeFo-Prinzips nicht gewährleistet.
 - Im Falle eines Rückrufes einer Charge kann ein Blister der betreffenden Charge übersehen werden, weil er nicht in seiner Originalschachtel aufbewahrt wird.
- Arznei- und Desinfektionsmittel dürfen nicht in andere Behältnisse umgefüllt werden.
 - Rückstände aus dem Fremdbehälter können zur Kontamination des Arznei- bzw. Desinfektionsmittels führen.
 - Die Stabilität des Arznei- bzw. Desinfektionsmittels kann durch das Umfüllen negativ beeinflusst werden.
 - Charge und Verfalldatum werden oft nicht auf die neue Verpackung übertragen und sind nach dem Umfüllen nicht mehr ersichtlich.
 - Es besteht ein großes Risiko, dass die Arzneimittelsicherheit durch nicht eindeutige Kennzeichnung gefährdet wird.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

	Umgang mit Arzneimitteln	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Es dürfen keine Kartons auf dem Boden gelagert werden (Nährlösungen, Infusionslösungen, etc.).
 - In diesem Bereich ist anderenfalls keine angemessene Bodenreinigung möglich.
- Arzneimittel, die von Bewohnern mitgebracht wurden, müssen separat von den anderen Arzneimitteln aufbewahrt werden.
 - Bei Entlassung des Bewohners sind ihm seine mitgebrachten sowie die spezifisch für ihn bestellten Arzneimittel mitzugeben.
- Die Pflegefachpersonen müssen jederzeit Zugriff zu den aktuellen Arzneimittelinformationen haben. Mögliche Informationsquellen sind:
 - Die rote Liste (Buch oder Online).
 - Packungsbeilage der Arzneimittel.

2. Kühl- Ware

- Kühl Ware erhalten Sie von der Apotheke in einer Kühlbox; diese ist nur für den Transport vorgesehen. Die Arzneimittel müssen nach der Auslieferung unverzüglich im Kühlschrank des Wohnbereiches gelagert werden. Die Kühlbox mit den Arzneimitteln darf nicht in einem Kühlraum oder –Schrank zwischengelagert werden, da dann die Gefahr von Minustemperaturen und des Anfrierens der Arzneimittel besteht.
- Lagern Sie kühl aufzubewahrende Arzneimittel nur in hierfür geeigneten Kühlschränken. Die Temperatur muss durchgehend in einem Bereich von 2 bis 8°C liegen (Diese Angaben gelten für Arzneimittel).
 - Nach Möglichkeit sollten ausschließlich Arzneimittelkühlschränke verwendet werden, da nur diese eine ausreichend genaue Temperaturregelung und die ideale Lagerung der Arzneimittel garantieren.
 - Bei Verwendung von Haushaltskühlschränken dürfen in den Tür- und Gemüsefächern KEINE Arzneimittel gelagert werden, da die Temperaturen an diesen Stellen deutlich über den Temperaturen des Innenraumes und in der Regel oberhalb des geforderten Bereiches liegen.
 - Arzneimittel sollen in der Mitte der Fächer lagern und nicht in der Nähe von Gefrierfächern aufbewahrt werden, um ein Anfrieren zu vermeiden.
- Temperaturkontrolle: Die Einhaltung des Temperaturbereiches von 2 bis 8°C muss überwacht werden.
 - Kontrollieren Sie die Temperaturen einmal täglich (alle 24 Stunden) mit einem Minimum-Maximum-Thermometer und protokollieren sie auf dem „Temperaturkontrolle Medikamentenkühlschrank“.
 - Arzneimittelkühlschränke verfügen über eine Temperaturüberwachungseinheit, welche einen Alarm auslöst, sobald die Temperatur außerhalb des Sollbereiches liegt. Bitte informieren sie in diesem Falle unverzüglich den technischen Dienst.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

	Umgang mit Arzneimitteln	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Bewahren Sie im Arzneimittelkühlschrank aus hygienischen Gründen keine Lebensmittel auf.
- Halten Sie den Kühlschrank sauber. Bei Lebensmittelkühlschränken mit integriertem Eisfach muss dieses regelmäßig enteist werden.

3. Betäubungsmittel

- Betäubungsmittel (BTM) müssen grundsätzlich unter Verschluss und separat von anderen Arzneimitteln aufbewahrt werden. Der Schlüssel zum Betäubungsmittelschrank muss sich immer bei der schichtführenden Pflegefachkraft befinden.
- Führen Sie pro Präparat ein Betäubungsmittel-Kontrollblatt, auf dem alle Ein- und Ausgänge dokumentiert werden.
- Orale BTM-Lösungen: pro Flasche wird ein neues Kontrollblatt geführt, wobei die Ausgänge, wenn immer möglich in Milliliter ansonsten in Tropfen dokumentiert werden.
- BTM dürfen vorgerichtet werden, wenn gewährleistet werden kann, dass die Arzneimittel vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt sind.
- **BTM-Zwischenfälle, also Fehlbestände oder Diebstähle, müssen umgehend der Pflegedienstleitung gemeldet werden!**

4. Richten der Arzneimittel für Patienten

- Hände vor Beginn desinfizieren; dies ist besonders wichtig bei aseptischen Prozessen (z.B. Aufziehen von Spritzen aus Ampullen) oder bei einem direkten Kontakt mit dem Arzneimittel.
- Um die Gefahr von Verwechslungen und die Gabe falscher Dosen zu minimieren, sollten sich während des Richtens möglichst wenige Personen im Raum aufhalten, damit ein ungestörtes Arbeiten möglich ist.
- Vorgehen beim Teilen von Tabletten
 - Es sollte immer abgeklärt werden, ob die Tablette zum Teilen geeignet ist.
 - Auch beim Mörsern von Tabletten ist immer vorab mit dem verschreibenden Arzt abzuklären, ob die Tabletten hierfür geeignet sind.
- Für das Teilen von Tabletten ist ein Tablettenteiler zu verwenden oder:
- Gewölbte Tabletten oder Snap-Tab's auf einer harten Unterlage mit der Bruchkerbe nach oben teilen.
- Flache Tabletten über den Nägeln beider Daumen oder durch Daumendruck über beiden Zeigefingern mit der Bruchkerbe nach oben teilen.
- Bei einem großen Bruchkerbenwinkel einer Tablette kann durch Fingerdruck auf die ungekerbte Seite gegen eine harte Unterlage gebrochen werden.
- Oft stehen auch Hinweise für das Teilen der jeweiligen Tablette in der Packungsbeilage.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

	Umgang mit Arzneimitteln	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Was ist zu tun mit der zweiten, nicht sofort verwendbaren Hälfte der geteilten Tablette?
 - Wenn die Tabletten aus einer Blisterpackung stammen, muss die zweite Hälfte aus Gründen der Arzneimittelsicherheit, Stabilität und Hygiene verworfen werden.
 - Wenn die Tabletten aus einem Mehrdosenbehältnis (Arzneiglas, Dose...) stammen, kann die zweite Hälfte unmittelbar nach dem Teilen in das Behältnis zurückgelegt werden. (Bsp. Marcumar, Madopar etc.)
 - Sollte die Tablette beim Teilen in unterschiedlich große Teile zerbrechen, sind diese zu verwerfen, da die in den Bruchstücken enthaltene Wirkstoffdosis unklar ist.
- Vorgehen beim Mörsern von Tabletten
 - Es sollte immer abgeklärt werden, ob die Tablette zum Mörsern geeignet ist.
 - Die Tabletten müssen einzeln gemörsert werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- Teilbarkeit von Pflastern, Matrix-Pflastern:
 - Pflaster zur transdermalen Verabreichung von Arzneimitteln, sollten in der Regel nicht zerschnitten werden. Soll in einem Ausnahmefall ein Pflaster geteilt werden, ist zu beachten, dass **NICHT** alle Pflaster zerschnitten werden dürfen. Es muss zuvor mit dem Hausarzt und bei Unklarheit mit der Apothekerin geklärt werden, ob dies möglich ist.
- Umgang mit flüssigen und halbfesten Arzneiformen:
 - Beschriften Sie nach dem erstmaligen Öffnen von Flüssigkeiten und halbfesten Arzneiformen die Verpackung mit dem Anbruch Datum und dem Haltbarkeitsdatum, welches, gemäß des Beipackzettels, ermittelt werden kann. Bei Tropfen und Insulinen sind auch die Flaschen und Pens zu beschriften. Beachten Sie, dass manche dieser Arzneimittel nach Anbruch im Kühlschrank gelagert werden müssen.
 - Tropfflaschen mit Tropfeinsätzen sind meistens Senkrechttropfer (es gibt auch Rand Tropfer, daher immer Packungsbeilage beachten). Schräghalten der Flasche bei Senkrecht Tropfern führt zu kleineren Tropfen und somit zu einer potenziellen Unterdosierung. Halten Sie daher die Tropfflasche im Fall von Senkrecht Tropfern zur Entnahme senkrecht nach unten. Senkrecht Tropfer werden also senkrecht gehalten, Rand Tropfer sind seltener und werden im 45° Winkel gehalten.
 - Die Flasche soll bis zum letzten Tropfen senkrecht gehalten werden. Klopfen Sie, wenn nötig, zum antropfen leicht auf den Flaschenboden, vermeiden Sie jedoch ein Schütteln bzw. starkes Hin- und Herschwenken der Flasche.
- Verlassen Sie den Arbeitsplatz nach dem Richten der Medikamente sauber, wischen Sie die Tische ab und lassen Sie keine Arzneimittel / Tabletten lose liegen.
- Nach dem Gebrauch von Flaschen und Tuben müssen diese wieder fest verschlossen werden.
- Nach dem Richten sind die Hände mit Seife zu waschen, um eventuelle irritative oder toxische Pulverrückstände der Tabletten zu entfernen.
- Die vorgerichteten Arzneimittel sind vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt aufzubewahren.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

	Umgang mit Arzneimitteln	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

5. Umgang mit Wochendispensern / Medikamenten bei Neueinzügen / Kurzzeitpflegen:

- Achten Sie darauf, dass beim Stellen von Wochendispensern jeder Wochentag einer Woche aufgeführt ist. Also in einer Wochenbox müssen die Tage Montag bis Sonntag vorhanden sein.
- Wenn Bewohner Medikamente mit in die Einrichtung bringen, müssen am Tag des Einzugs die Medikamente mit Namen, Einzugsdatum und dem Bestand beschriftet werden.

6. Umgang mit Blistern / Medikamenten allgemein / BTM bei Krankenhausaufenthalt / Versterben des Patienten:

- Wenn Patienten in ein Krankenhaus / Reha etc. verlegt werden oder versterben, und vorübergehend keine medikamentöse Versorgung durch unsere Einrichtung stattfindet, wird die Apotheke umgehend in Kenntnis gesetzt, dass sie keine weiteren Blister liefern soll.

Übrig gebliebene Wochenblister sind sachgemäß zu entsorgen und der Verbleib im Pflegebericht zu dokumentieren.

- Bei Auszug werden die Medikamente dem Patienten / Bevollmächtigten / Betreuer ausgehändigt. Die Abgabe der Medikamente muss im Pflegebericht dokumentiert werden.

Qualifikation/Durchführungsverantwortung:

- Pflegefachkräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, stellv. PDL, Teamleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA